

PREPARE MON CONCOURS

Résumé 31

CS / SROS / CSN / CSR



06 16 03 08 31



slit-anass

ANASS SLIT- INFIRMIER POLYVALENT

Outils législatifs pour l'organisation de l'offre de soins

1. La Carte sanitaire
2. Le SROS
3. Le Numerus clausus
4. Le PPP
5. Le régime des autorisations
6. La coordination institutionnelle

Outils de planification stratégique dans la réforme de santé

1. Carte sanitaire (CS)
2. Schéma régional de l'offre de soins (SROS)
3. Projet d'établissement hospitalier (PEH)
4. Normalisation des critères d'allocation des ressources
5. Budget programme (contractualisation)
6. Plans d'effectifs
7. Plan stratégique régional

LA CARTE SANITAIRE

L'organisation de l'offre de soins s'effectue conformément à la carte sanitaire et aux SROS

La carte sanitaire et le SROS ont pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins publique et privée, en vue

- ❖ De satisfaire de manière optimale les besoins en soins et services de santé de la population
- ❖ De réaliser l'harmonie et l'équité dans la répartition spatiale des ressources matérielles et humaines
- ❖ De corriger les déséquilibres régionaux et intra-régionaux
- ❖ Maîtriser la croissance de l'offre

La carte sanitaire définit, aux niveaux national et régional, les composantes de l'offre et notamment :

- ❖ Les types d'infrastructures et des installations sanitaires
- ❖ Les normes et les modalités de leur implantation territoriale

La carte sanitaire détermine au niveau national interrégional et pour chaque région :

Agrégat de l'infrastructure sanitaire existante :

L'importance, la nature et le bassin de desserte des infrastructures sanitaires et des installations fixes et mobiles publiques et privées à prévoir

3- les normes, les critères et les modalités d'implantation des infrastructures et des installations sanitaires

La carte sanitaire détermine également les réseaux de prise en charge de problèmes et risques particuliers de santé ainsi que les ressources humaines selon les besoins et les spécialités

La carte sanitaire est établie sur la base de

- ❖ L'analyse globale de l'offre de soins existante
- ❖ Des données géo-démographiques et épidémiologiques et en fonction du progrès technologique médical

La carte sanitaire est établie par l'administration centrale après avis de la commission nationale de l'offre de soin, pour une durée maximum de 10 ans. Elle doit être évaluée tous les 5 ans, et révisée le cas échéant. Conformément à la même procédure, en cas de changements majeurs des données ayant servi à son élaboration.

Composantes de la carte sanitaire

Un Contenant: Le Territoire Sanitaire

La carte sanitaire fixe le découpage sanitaire du territoire national, en fonction du bassin de desserte de la population et de ses caractéristiques épidémiologiques, géographiques, démographiques, socio-économiques et administratives.

Un Contenu: Les Prestations de Soins et Services

La carte sanitaire définit, aux niveaux national et régional, les composantes de l'offre et notamment les types d'infrastructures et des installations sanitaires

Une Organisation des Soins: Réseaux et Filières

La carte sanitaire détermine également les réseaux de prise en charge de problèmes et risques particuliers de santé

Des Critères et Normes d'Implantation

La carte sanitaire détermine les normes, les critères et les modalités d'implantation des infrastructures et des installations sanitaires

Objectifs de la carte sanitaire :

1. Assurer une meilleure disponibilité des services pour la population.
2. Améliorer l'accès aux services et réduire les inégalités.
3. Rationaliser le développement sanitaire du pays.
4. Déterminer le cadre adéquat pour le développement des infrastructures, des équipements lourds et des ressources humaines.
5. Disposer d'un instrument efficace de régulation de l'offre de soins.

Principes justificatifs de la carte sanitaire :

1. Des disparités dans l'état de santé.
2. Des inégalités dans la couverture sanitaire.
3. Des déficits patents dans l'offre de soins.
4. Des mutations importantes: transition démographique...
5. Mesure d'accompagnement du projet loi 131-13 relative à l'exercice de la médecine.

Le SROS

Le SROS constitue la base pour l'organisation des liens fonctionnels entre les secteurs public et privé, entre les régions et entre les préfectures et provinces les composant.

Le SROS détermine par préfecture ou province, eu égard à la carte sanitaire, en fonction du découpage sanitaire intra régional et sur la base de l'analyse des besoins :

1. L'inventaire de l'infrastructure sanitaire existante
2. La projection des établissements de santé, des lits et places, des spécialités, des installations fixes et mobiles publiques et privées et des équipements lourds ainsi que leur répartition territoriale
3. La répartition territoriale et les projections des effectifs des ressources humaines

En fonction des besoins, le SROS peut porter sur un domaine sanitaire spécifique ou sur l'organisation de ressources rares.

Le SROS sera établi par la direction régionale de la santé concernée, pour une période de 5 ans, après avis de la commission régionale de l'offre de soins

- ❖ C'est une référence pour une meilleure allocation des ressources.
- ❖ C'est un outil pour la détermination des objectifs prioritaires en matière de la santé.
- ❖ Une inexistence d'un cadre juridique (pas comme la carte sanitaire)
- ❖ C'est un moyen de découpage et d'aménagement de territoire
- ❖ C'est une vision globale centrée sur le patient et ses besoins en soins.
- ❖ C'est un levier de changement.

Principes du SROS :

1. Globalité
2. Intégration
3. Viabilité
4. Proximité
5. Équité
6. Souplesse

Objectifs du SROS :

1. Développer la planification stratégique régional.
2. Développer la concertation.
3. Favoriser l'intégration du système de soins.
4. Apporter une réponse adaptée.
5. Offrir une cadre de référence formelle.

Les composants du SROS :

1. Un plan stratégique régional.
2. Un plan de couverture sanitaire.
3. Un plan thématique.
4. Un plan de déploiement des effectifs.
5. Un plan de mobilisation des ressources.
6. Un plan de communication et de concertation.

Etapes de l'élaboration du SROS

1. Identification des problèmes et fixation des orientations
 - ❖ Diagnostic de la situation sanitaire par rapport aux besoins
 - ❖ Identification des problèmes
 - ❖ fixation des orientations
2. Mobilisation des ressources
3. Détermination des mesures à prendre
4. Programmation et évaluation: Dispositif de mise en œuvre, indicateurs d'évaluation etc.....

La Carte Sanitaire et le Schéma Régional de l'Offre de Soins ont pour objet :

Rôle de Planification:

1. Prévoir et Susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins public et privé

Rôle de Régulation:

1. Satisfaire de manière optimale les besoins en soins et services de santé de la population
2. Réaliser l'harmonie et l'équité dans la répartition des ressources matérielles et humaines
3. Corriger les déséquilibres régionaux et intra régionaux
4. Maitriser la croissance de l'offre

Planifier de l'offre de soins	Réguler de SNS
Dimension technique	Dimension politique
Méthodes, faits, analyses, projections, cartographies	Aménagements du territoire, redistribution des ressources, maitrise des dépenses, atténuations des inégalités
Mission décentralisée	Mission centralisée

La Carte Sanitaire détermine au niveau national, interrégional et pour chaque région, l'agrégat de l'Infrastructure sanitaire existante

Le Schéma Régional de l'offre de Soins détermine, par préfecture ou province, l'inventaire de l'infrastructure sanitaire existante; la projection des établissements de santé, des lits et places, des spécialités, des installations fixes et mobiles publiques et privés et des équipements lourds ainsi que leur répartition territoriale et les projections des effectifs des ressources humaines.

La Création et l'Implantation de tout établissement de santé public s'effectueront Conformément à la CS et au SROS.

La Création et l'Implantation des cliniques et établissements assimilés, des cabinets de radiologie et des laboratoires d'analyse de biologie médicale s'effectueront par Référence aux orientations de la CS et au SROS.

Les 8 principes régissant l'offre de soins et la CS

1. La Solidarité et la Responsabilisation
2. L'Egalité d'accès aux soins et services de santé
3. L'Equité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires
4. La Complémentarité Intersectorielle
5. L'Adoption de l'approche genre en matière des services de santé
6. L'Intégration et la Coordination
7. La Globalité
8. La Graduation des Soins

Selon la loi cadre 06-22 ;

Chaque groupement sanitaire territorial établit, dans le cadre des orientations générales de la carte sanitaire nationale, une carte sanitaire régionale de l'offre de soins qui comporte un inventaire global de l'offre de soins dans les secteurs public et privé et détermine, pour le secteur public, les mesures et les dispositions à même de garantir :

- ❖ La satisfaction, de manière optimale, des besoins de la population en soins et prestations de santé au niveau régional et ce, en établissant les projections relatives notamment, aux ressources humaines, aux établissements de santé, aux lits et places, aux spécialités, aux installations fixes et mobiles, aux équipements lourds ainsi que leur répartition spatiale
- ❖ L'harmonie et l'équité dans la répartition des ressources humaines et matérielles au niveau régional
- ❖ La réduction des disparités au sein de la région concernée en matière de l'offre de soins.

Chaque carte sanitaire régionale de l'offre de soins est établie pour une durée déterminée. Elle peut être mise à jour en cas de changements survenus dans les orientations générales contenues dans la carte sanitaire nationale.